

Efekt naruszenia *abstynencji*

Marlatt: różnica między „lapsusem” (jeden epizod) a „nawrotem” (powrót do wzorca) leży w reakcji na lapsus. AVE — pułapka „skoro już złamałem, mogę dalej”.

CZAS: 30 min refleksja Po doświadczeniu lapsusu **ŹRÓDŁO:** Marlatt & Gordon (1985); Brown (2010)

JAK UŻYWAĆ

AVE (ang. *Abstinence Violation Effect*) — efekt naruszenia abstynencji, opisany przez Marlatta. Karta przedstawia: 1) różnicę między **lapsusem** (jeden epizod) a **nawrotem** (powrót do wzorca), 2) **mechanizm AVE** (3 składniki), 3) jak *nie* reagować na lapsus, 4) protokół powrotu po lapsusie.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Marlatt zauważył: **nie jest tak, że każdy lapsus prowadzi do nawrotu**. Decyduje *reakcja* na lapsus. Pacjent A po jednym epizodzie mówi: „OK, zdarzyło się, analizuję, wracam do planu” — następne dni stabilne. Pacjent B po identycznym lapsusie: „jestem porażką, już dziś stracone, mogę dalej” — pełny nawrót przez tydzień. Różnica nie tkwi w samym lapsusie, ale w *interpretacji i reakcji emocjonalnej*. AVE jest **pułapką poznawczą** — uniwersalną w uzależnieniach. Kluczowa *wiedza*: znając mechanizm AVE, pacjent może świadomie przerwać spiralę. Marlatt & Gordon (1985): pacjenci edukowani o AVE mają **60% mniej** długotrwałych nawrotów po lapsusie.

01 Lapsus vs nawrót — kluczowa różnica

LAPSUS (SLIP)

Pojedynczy epizod po okresie abstynencji.

Pacjent: „OK, zdarzyło się. Analizuję, wracam do planu, dzwonię do terapeuty.”

Reakcja: *chłodna analiza*, brak biczowania, kontynuacja pracy.

Konsekwencja: następny dzień znowu stabilny. Lapsus nie zwiększa znacząco ryzyka kolejnego.

NAWRÓT (RELAPSE)

Powrót do wzorca — kilka epizodów w tygodniach.

Pacjent: „jestem porażką, wszystko stracone, nie warto walczyć, mogę dalej”.

Reakcja: *katastroficzne myślenie*, samobiczowanie, rezygnacja z planu.

Konsekwencja: pełny powrót do dawnych wzorców, czasem na miesiące.

Klucz: różnica nie tkwi w samym epizodzie. Tkwi w *tym, co dzieje się w głowie* po epizodzie. AVE jest mostem między lapsusem a nawrotem — można go zburzyć.

02 = Mechanizm AVE — 3 składniki

1 · ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA

„Złamałem, bo jestem słaby / wadliwy / nie potrafię”.

Vs zdrowo: „złamałem, bo była sytuacja wysokiego ryzyka i nie zastosowałem strategii”.

2 · GENERALIZACJA

„Skoro złamałem dziś, to znaczy że **całe ja** jest stracone”.

Vs zdrowo: „jeden epizod nie definiuje całego procesu”.

3 · PERMISYWNOŚĆ

„Skoro już złamałem, mogę dalej dziś — i tak stracone”.

Vs zdrowo: „jeden epizod nie zmienia stawki — dalej dziś to zwielokrotnienie szkody”.

03 ● Protokół po lapsusie — 6 kroków

1 • Zatrzymaj się. Fizycznie. Wyjdź z miejsca epizodu. Zmień otoczenie. Daj sygnał „koniec”.

2 • Bez biczowania. Powiedz sobie głośno: „To był lapsus, nie definiuje mnie. Wracam do planu.”

3 • Skontaktuj się. Z osobą z sieci wsparcia / terapeutą. Powiedzenie głośno rozbraja AVE.

4 • Analiza, nie ocena. Zapisz: co poprzedzało, jakie PND, jakie myśli, jakie uczucia. Z ciekawością.

5 • Plan ucia z dziś. Następne 12 h jest najtrudniejsze. Zaplanuj: ludzie, miejsce, aktywność. Brak wolnego czasu.

6 • Wraca jutro. Następny dzień — normalny dzień planu. Bez ekspiacji, bez „nadrabiania”. Wraca rutyna.

04 ✎ Twoje doświadczenie z AVE

CZY W PRZESZŁOŚCI DOŚWIADCZYŁEM/-AM AVE

— lapsus → spirala myśli → nawrót

KTÓRY Z 3 SKŁADNIKÓW AVE JEST U MNIE NAJSILNIEJSZY

— atrybucja, generalizacja, permissywność

MÓJ PROTOKÓŁ POWROTU — KOGO ZADZWONIĘ

— 2–3 osoby, numery

Klucz: Brown (2010) dodaje *kluczowe* obserwację: AVE jest **wzmocnione** przez wstyd. Pacjent ze schematem wstydu (gdy bazą jest „jestem zły”) jest *szczególnie* podatny na AVE — każdy lapsus potwierdza schemat, schemat napędza permissywność, permissywność prowadzi do nawrotu. Pacjent z *autosympatią* może powiedzieć: „Tak, zdarzyło się. Jestem człowiekiem. Pracuję dalej.” — i wraca do planu. Praktyczna rada: **pełna autosympatia jest najsilniejszą szczepionką** przeciw AVE. Karta „Autosympatia (CFT)” jest komplementarna do tej. Razem dają pacjentowi narzędzie do utrzymania trajektorii, nawet gdy są potknięcia.